Centre hospitalier de Valmorin
Service de cardiologie et soins intensifs
12, avenue des Tilleuls · 38960 Valmorin · Secrétariat : 04 76 00 18 42

Docteur Hélène Marchetti
Cabinet médical du Pré-Vert
5, rue Basse
38970 Saint-Aubin-la-Roche

Valmorin, le 14 octobre 2026

Objet : M. Raymond Delaunay, né le 3 mars 1951, hospitalisé du 6 au 13 octobre 2026

Lettre de sortie d'hospitalisation

Chère consœur,

Je vous adresse le compte rendu d'hospitalisation de votre patient, admis par les urgences pour une douleur thoracique survenue au repos. L'évolution a été favorable et le patient regagne son domicile ce jour.

Motif d'hospitalisation

Douleur rétrosternale constrictive de trente minutes, irradiant vers le bras gauche, sans facteur déclenchant identifié. L'électrocardiogramme initial montrait un sous-décalage du segment ST en territoire latéral.

Antécédents

- Hypertension artérielle traitée depuis 2014
- Dyslipidémie sous régime seul
- Tabagisme sevré en 2009 (25 paquets-années)
- Appendicectomie dans l'enfance

Examens complémentaires

Biologie

Tableau 1 – Résultats biologiques

Paramètre	Résultat		Valeurs de référence	Unité
	Entrée	Sortie		
Troponine T hypersensible	86	19	< 14	ng/L
Hémoglobine	13,9	13,4	13,0 – 17,0	g/dL
Créatinine	92	88	64 – 104	µmol/L
Potassium	4,1	4,3	3,5 – 5,0	mmol/L
LDL cholestérol	1,62		< 0,55 (objectif)	g/L

Imagerie

La coronarographie du 7 octobre a mis en évidence une sténose serrée de l'artère circonflexe moyenne, traitée par angioplastie avec pose d'un stent actif. L'échocardiographie retrouve une fraction d'éjection ventriculaire gauche conservée à 58 %, sans valvulopathie significative.

Traitement de sortie

Médicament	Posologie	Durée
Acide acétylsalicylique 75 mg sachet	1 sachet le midi	Au long cours
Ticagrélor 90 mg comprimé pelliculé	1 comprimé matin et soir	12 mois
Atorvastatine 80 mg comprimé	1 comprimé le soir	Au long cours
Bisoprolol 2,5 mg comprimé sécable	1 comprimé le matin	Au long cours
Ramipril 5 mg gélule	1 gélule le matin	Au long cours

Le patient a reçu une éducation thérapeutique sur la double antiagrégation plaquettaire et sur la conduite à tenir en cas de récidive douloureuse.

Suivi proposé

– Consultation de cardiologie dans six semaines avec électrocardiogramme
– Bilan lipidique et hépatique à un mois
– Programme de réadaptation cardiaque à débuter dans les quinze jours
– Arrêt de la conduite automobile pendant une semaine

Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. Veuillez agréer, chère consœur, l'expression de mes sentiments confraternels.

Docteur Antoine Ferrand-Lacoste
Praticien hospitalier, cardiologie